UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

(Dermatologie)
(Psoriasis - sujet 2)
sans patient
sans geste clinique

Nom du rédacteur : Montagne Léa Date de rédaction : 23/11/2023

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ :

N° 37 – Eruptions chez l'enfant

N° 67 – Douleurs articulaires

N° 81 – Anomalie des ongles

N° 88 – Prurit

N°328 – Annonce d'une maladie chronique

Domaine de compétence n°1 : Iconographie

Domaine de compétence n°2 : Stratégie de prise en charge

Attendus d'apprentissage de la situation abordée :

1. Connaître la fréquence du psoriasis dans la population française
2. Connaître la physiopathologie du psoriasis
3. Connaître les modalités du diagnostic d'un psoriasis en plaques classique
4. Connaître les trois formes graves de psoriasis
5. Connaître les principaux diagnostics différentiels du psoriasis
6. Connaître les modalités du diagnostic des formes cliniques articulaires du psoriasis
7. Savoir reconnaître un psoriasis chez l'enfant
8. Connaître les principales pathologies associées au psoriasis

9. Connaître les principes de la prise en charge thérapeutique du psoriasis

Patient simulé nécessaire à la station : NON

Matériel nécessaire à la station

- Tablette pour l'iconographie (photographie de psoriasis)

Instructions à l'étudiant

Vous êtes dermatologue en cabinet. Dans le cadre de la téléexpertise, un médecin généraliste vous contacte au sujet d'une patiente, Madame GONZALES. Il vous a transmis un compte rendu et des photographies issues de son examen clinique

Vous avez **8 minutes** pour :

1. **Décrire** ce que vous voyez sur les photographies.
2. Proposer le **diagnostic** le plus probable et **2 diagnostics différentiels**
3. Evaluer **la sévérité** de la pathologie
4. Proposer la **prise en charge.**

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tâche 1	
1ère photo CHEVEUX : Décrit des plaques érythémateuses, bien limitées, de plusieurs centimètres, arrondies, couvertes de larges squames épaisses, traversées par les cheveux et de localisation occipitale. *Rempli si 3/7 caractéristiques décrites.*	
2e photo DOS : Décrit des papules ou des plaques érythémateux-squameuse bien limitées, arrondies, ovalaires ou polycycliques, multiples et symétriques, de localisation caractéristique de la région lombo-sacrée et au niveau des coudes. *Rempli si 3/7 caractéristiques décrites.*	
3e photo SIF : Décrit un psoriasis inversé du pli interfessier, avec plaques érythémateuses vernissées et bien limitées. *Rempli si 3/5 caractéristiques décrites.*	
4e photo MAIN : Décrit une kératodermie palmaire diffuse et fissuraire. *Rempli si 1/3 caractéristiques décrites.*	
Tâche 2	
Pose le diagnostic de psoriasis.	x
Elimine les diagnostics différentiels : Pityriasis rosé de Gibert, Dermite séborrhéique, eczéma, dermatophytie, lymphome cutané *Rempli si 1/5 mentionné.*	
Tâche 3	
Elimine les 3 formes graves de psoriasis : le rhumatisme psoriasis, le psoriasis érythrodermique et le psoriasis pustuleux.	
Évalue le psoriasis de modéré à sévère en justifiant que la surface cutanée atteinte est de plus de 10 % (plus de 10 fois la surface cutanée de la paume de main de la patiente).	
Tâche 4	
Propose une consultation d'annonce en cabinet afin de mettre en place une stratégie au long cours comme dans toute maladie chronique.	
Conseille d'éviter le stress, le tabac et l'alcool.	
Prévoit de prendre en compte le retentissement psychologique.	
Propose des traitements locaux : dermocorticoïdes, analogues de la vitamine D3 ou leur association.	x
Explique qu'au vu de l'étendue du psoriasis, on peut proposer d'emblée un traitement général (la photothérapie, l'acitrétine, le méthotrexate, la ciclosporine). *Rempli si 2/4 mentionnés.*	
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
Aptitude à faire la synthèse des données.	1 à 5
Aptitude à proposer une prise en charge.	

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Cocher si fait
Tâche 1	
1ère photo : Décrit des plaques bien limitées, de plusieurs centimètres, arrondies, couvertes de larges squames épaisses, traversées par les cheveux et de localisation occipitale. *Rempli si 3/7 caractéristiques décrites.*	1
2e photo : Décrit des papules ou des plaques érythémato-squameuse bien limitées, arrondies, ovalaires ou polycycliques, multiples et symétriques,de localisation caractéristique de la région lombo-sacrée et au niveau des coudes. *Rempli si 3/7 caractéristiques décrites.*	1
3e photo : Décrit un psoriasis inversé du pli interfessier, avec plaques érythémateuses vernissées et bien limitées. *Rempli si 3/5 caractéristiques décrites.*	1
4e photo : Décrit une kératodermie palmo-plantaire diffuse et fissuraire. *Rempli si 1/3 caractéristiques décrites.*	1
Tâche 2	
Pose le diagnostic de psoriasis.	1
Elimine les diagnostics différentiels : Pityriasis rosé de Gibert, Dermite séborrhéique, eczéma, dermatophytie, lymphome cutané *Rempli si 1/5 mentionné.*	1
Elimine les 3 formes graves de psoriasis : le rhumatisme psoriasis, le psoriasis érythrodermique et le psoriasis pustuleux.	1
Évalue le psoriasis de modéré à sévère en justifiant que la surface cutanée atteinte est de plus de 10 % (plus de 10 fois la surface cutanée de la paume de main de la patiente).	1
Tâche 3	
Propose une consultation d'annonce en cabinet afin de mettre en place une stratégie au long cours comme dans toute maladie chronique.	1
Conseille d'éviter le stress, le tabac et l'alcool.	1
Prévoit de prendre en compte le retentissement psychologique.	1
Propose des traitements locaux : dermocorticoïdes, analogues de la vitamine D3 ou leur association.	1
Explique qu'au vu de l'étendue du psoriasis, on peut proposer d'emblée un traitement général (la photothérapie, l'acitrétine, le méthotrexate , la ciclosporine). *Rempli si 2/4 mentionnés.*	1
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
Aptitude à faire la synthèse des données.	1 à 5
Aptitude à proposer une prise en charge.	